

中医二羊整理：中医把脉手把手教，最全动图展示并心法口诀，建议收藏！

养阳医斋 2019年4月6日 11:08

大家好，我是中医二羊，借助清明节假日，跟大家分享一下中医把脉的精华。

都说中医把脉很玄乎，其实只要你了解中医把脉的原理，中医把脉是为了获取什么信息，你就不会有这样的困惑。

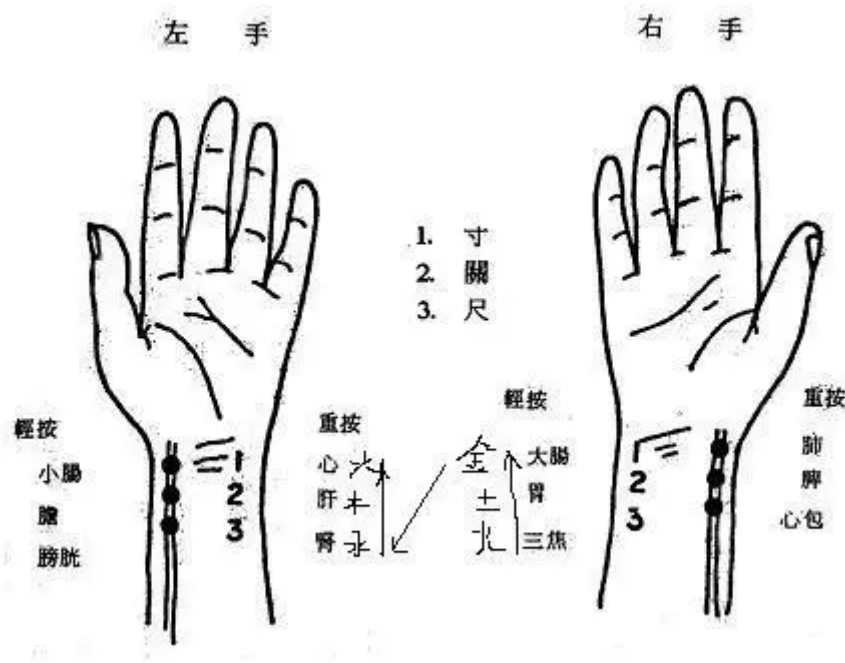
中医号脉从古代一直被沿用传承至现在，足以可见它的强大生命力和科学性。中医自古便有号脉这一绝学。望，闻，问，切始终以普遍应用的技巧，尤其是切脉，这是一个非常具有神奇性的技巧。

中医号脉其实就是医生用手指触按病人的动脉搏动，以探查脉象，从而了解病情的一种诊断方法。其实中医把脉最关键不是为了诊断出一个西医病名，而是帮助辩证知道治疗和用药。

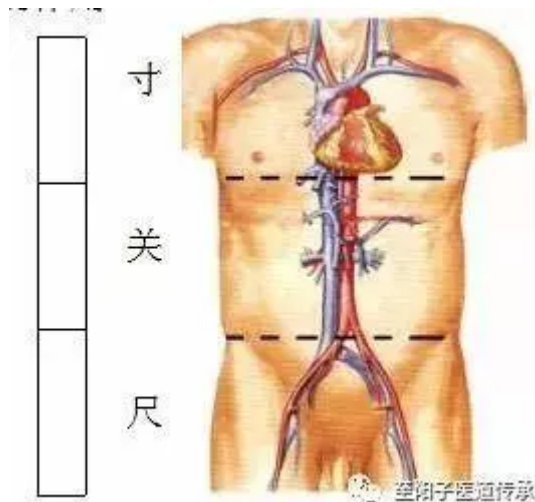
健康人的脉

要了生病的脉象，首先得了解健康人的脉是怎样的。

健康人的脉象称为正常脉象。一般是不浮不沉，不大不小，不强不弱，不快不慢，均匀和缓，节律整齐，又称为平脉或缓脉。平脉至数清楚，一息(即一呼一吸)之间四至五次，相当于72~80次，节律、强弱一致。



脉象受体内外因素的影响而发生生理的或暂时的变化，也属正常。如年龄越小，脉跳越快，婴儿脉急数，每分钟120~140次；五、六岁儿童常为一息六至，每分钟90~110次；青壮年体强，脉多有力；年老人体弱，脉来较弱；成年人女性较成年男性脉细弱而略快；瘦人脉较浮，胖人脉多沉；重体力劳动，剧烈运动长途步行，饮酒饱餐，情绪激动，脉多快而有力，饥饿时则脉较弱。

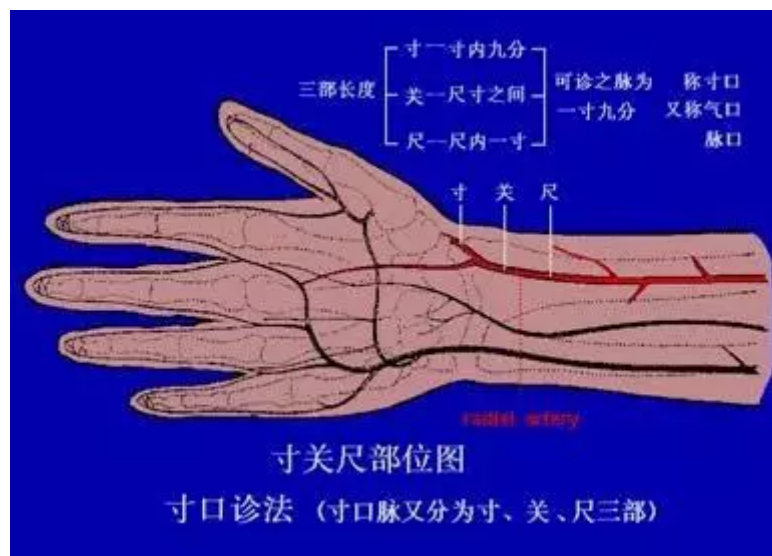


1、大小：

管察气：大气旺，小气虚。

2、快慢：

管察精：快精虚，慢精足。



3、硬软：

管察火：硬火多，软火少。

4、浮沉：



管表里：[亦可说阴阳] 浮表症，沉里症。

5、匀乱：

管察安危：匀则生命及心脏平安，乱则生命及心脏危险。



常见的异常脉象：

浮脉

是脉动显现部位表浅的一种脉，轻取即得，重按反而变弱。一般情况下，提示病邪在表。脉浮而有力者为表实，浮而无力者为表虚。

沉脉

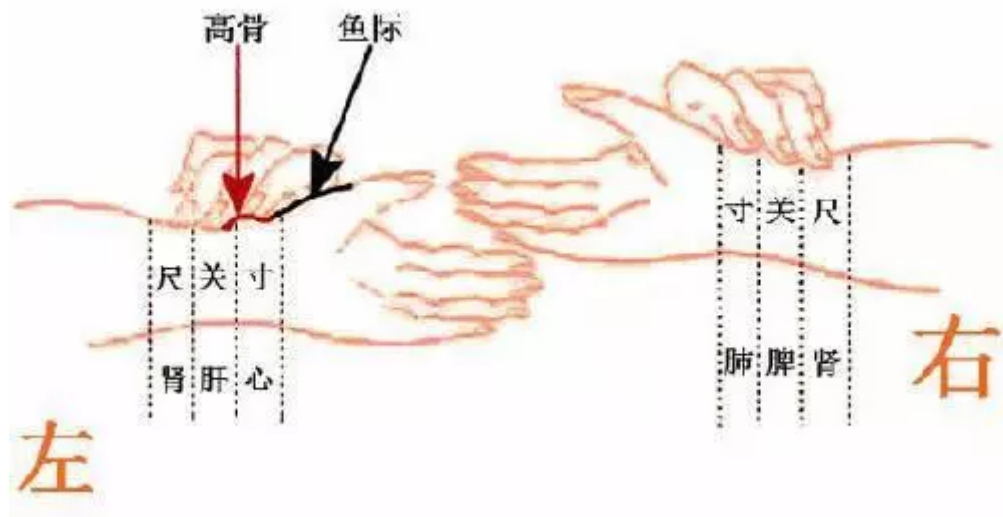
是脉动显现部位较深的一种脉，轻取不得，重按始见。通常主里证，沉而有力者为里实证，沉而无力者为里虚证。

迟脉

脉来较慢，每分钟60次以下。多主寒证，因寒可使血流速度减慢。迟而有力者为冷积实证，迟而无力者为阳虚证。

数脉

脉来较快，每分钟90次以上，来去急促。多主热证，因热可使血流速度加速，数而有力者为实热证，数而无力者为虚热证。



细脉

又称小脉，脉如细线，软弱少力，但应指尚明显。是湿证与虚证之象。因湿邪阻滞脉道或气血虚而不能充盈脉道所致。

洪脉，脉体阔大，充实有力，来盛去衰，状如洪水。大多主邪热亢盛的实证。

弦脉，脉形端直，如按琴弦。常见于有肝胆病、痰饮证、疼痛证的患者。

滑脉，脉来流（滑）利，如盘走珠。是实热证、痰饮证、伤食证，或妊娠的脉象。

涩脉

脉来艰涩不畅，如轻刀刮竹。为气滞证、瘀血证、精血亏少证之征象。

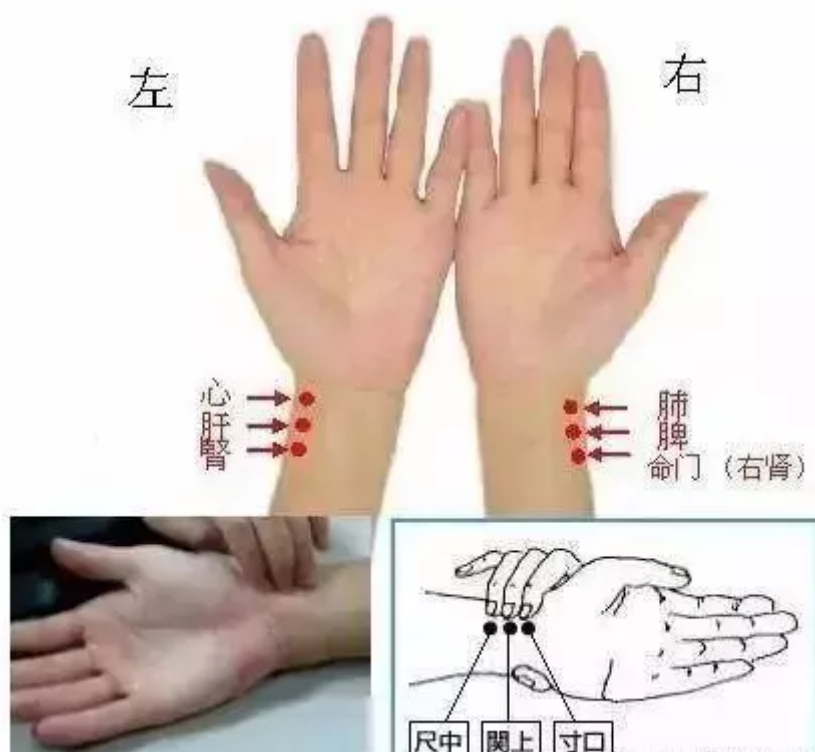
虚脉

三部脉举按皆无力，隐隐蠕动于指下，为一切无力脉之总称。是虚证之象，主要为气虚或

气血两虚证。

实脉

三部脉举按皆有力，脉来盛而坚实，为一切有力脉的总称。是实证之象，提示邪气实而正气不虚。



号脉方法：

早期的切脉方法比较复杂，要切按头颈、手、足等多处部位的脉动。以后逐渐简化为只切按手腕部的脉搏，称为“寸口”诊法。在这短短寸许长的脉动部位上，古代医家做足了文章。他们将腕横纹向上约一寸长的这段脉动分成了三“寸、关、尺”三部。

左右手的寸、关、尺部位分属不同的脏腑，认为可以反映相应脏腑的病变。其中右寸反映肺的情况，右关反映脾胃，右尺反映肾（命门）；左寸反映心，左关反映肝，左尺反映肾与膀胱。

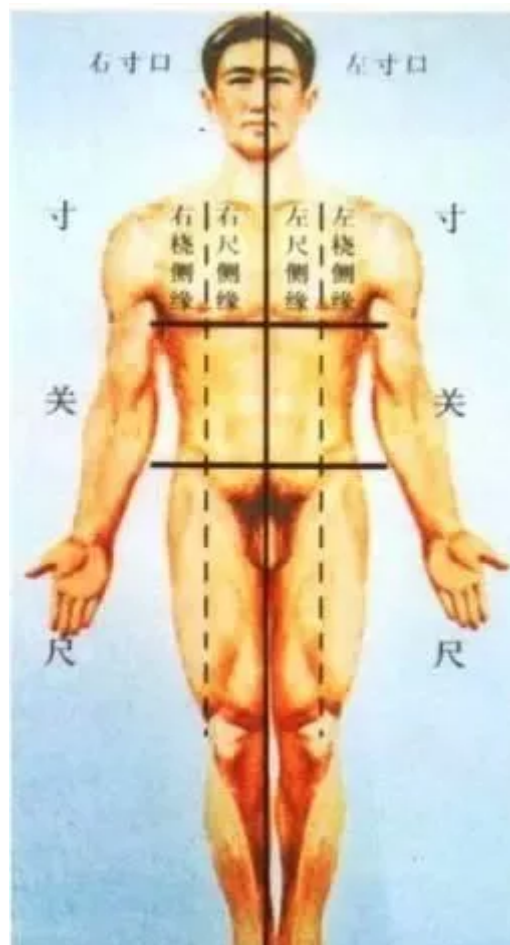
仔细观察，大家可以发现：远端的寸部对应的是人体最上部的心、肺（上焦，呼吸与循环系统）；中间的关部，对应肝、脾胃（中焦，消化系统）；近端的尺部对应肾、膀胱（下焦，泌尿生殖系统）。如此，小小的“寸口”，却俨然成为人体五脏六腑的全息窗口。

仅此还不够，在切脉的时候，还要用三种不同的指力去按压脉搏，轻轻用力按在皮肤上为“浮取”；中等度用力按至肌肉为“中取”；重用力按至筋骨为“沉取”。寸、关、尺三部，每一部有浮、中、沉三候，合称为“三部九候”。不同手法取到的脉，临床意义不同。通常，脉浮于外者，病位浅，沉于里者病位深。

切脉时还有许多讲究。首先，要求安静，包括外环境的安静与医患两者心神的安静。患者在诊脉前要休息片刻，待安静后方可诊脉。医者切脉前一定要静心，调整呼吸，并将注意力完全集中于指下，细心切按一分钟以上。诊脉时患者取坐位或仰卧位，手臂与心脏保持同一水平位，手腕舒展，掌心向上。

其次，切按时医者用三指定位，即先以中指指定好关部，再根据患者身高调整三个手指的疏密。若患者身材高大，布指宜疏；矮小者，布指宜密，小儿则用一指（拇指）诊脉，不分三部。

学习诊脉，必须先了解正常的脉象。正常脉称为“平脉”、“常脉”。每分钟跳动70—80次左右，节律规则，脉型不粗不细，不浮不沉，不刚不弱。但正常脉象常随季节、年龄、性别、体质等会有差异。如春、夏、秋季的脉大多偏浮，而且搏动有力；冬季的脉多沉伏于里。年龄越小脉搏越快，青壮年脉多强而有力，老年人的脉较弱；身材高大的人脉多长，矮小的人脉较短，瘦人脉多浮，胖人脉多沉；饱食后及情绪激动时脉多快而有力，饥饿时脉多软弱。如果发现相反脉象，如冬天脉浮、胖人脉浮、瘦人脉沉等，提示脉象异常。



实用举例

如肝硬化的脉：快，小，硬，沉，[两关独居中]。套入脉理，则为精亏，气虚，火多，

里即病在内脏，两关微浮一些，为气火位于肝胃，[我又把它戏为黄豆脉，一切癌症艾滋病白血病均为黄豆脉]，你叫我看病，不用你出声，我一看脉就能说出你有什么病，好玩吧？

比如感冒的脉：大，浮，硬，快，套入脉理，为气旺，病表[表即躯体感冒属表症]火多，精亏，看到这样的脉，你说你肚疼，那你在说谎，一摸你的脉，你体内隐藏的病，便无处躲藏，现形毕露，好玩吧？只要你到了这种水平，心情就愉快了。

李时珍脉诀总结了中医常见的脉象和主病，不得不感谢古人的智慧。方便了我们后人学习

28脉分脉脉歌及全部脉象动态图

浮脉

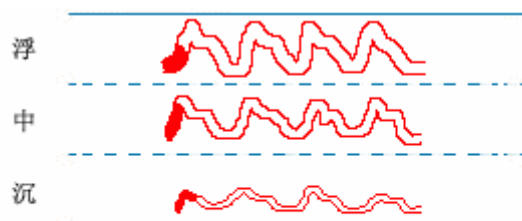


图 6-8 (1) 浮脉示意图

【体象歌】浮在皮毛，如水漂木；举之有余，按之不足。

【主病歌】浮脉为阳，其病在表。寸浮伤风，头疼鼻塞；左关浮者，风在中焦；右关浮者，风痰在膈；尺脉得之，下焦风客，小便不利，大便秘涩。

【兼脉歌】无力表虚，有力表实。浮紧风寒，浮迟中风；浮数风热，浮缓风湿。浮芤失血，浮短气病；浮洪虚热，浮虚暑惫；浮涩血伤，浮濡气败。

沉脉

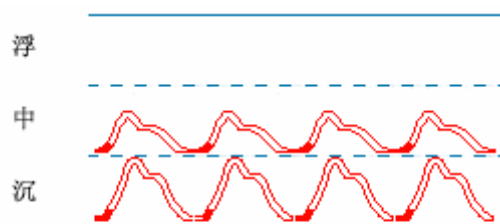


图 6-10 (1) 沉脉示意图

【体象歌】沉行筋骨，如水投石；按之有余，举之不足。

【主病歌】沉脉为阴，其病在里。寸沉短气，胸痛引胁；或为痰饮。或水与血。关主中寒，因而痛结；或为满闷，吞酸筋急。尺主背痛，亦主腰膝；阴下湿痒。淋浊痢泄。

【兼脉歌】无力里虚，有力里实。沉迟痼冷，沉数内热；沉滑痰饮，沉涩血结；沉弱虚衰，沉牢坚积；沉紧冷疼，沉缓寒湿。

迟脉

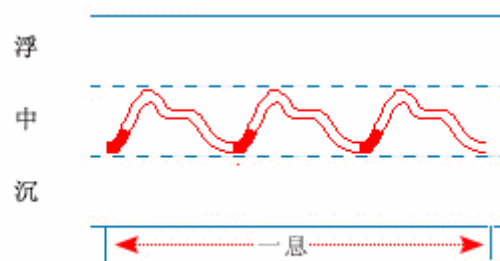


图 6-12 (1) 迟脉示意图

【体象歌】迟脉属阴，象为不及；往来迟慢，三至一息。

【主病歌】迟脉主脏，其病为寒。寸迟上寒，心痛停凝；关迟中寒，癥结挛筋；尺迟火衰，溲便不禁，或病腰足，疝痛牵阴。

【兼脉歌】有力积冷，无力虚寒。浮迟表冷，沉迟里寒；迟涩血少，迟缓湿寒；迟滑胀满，迟微难安。

数脉

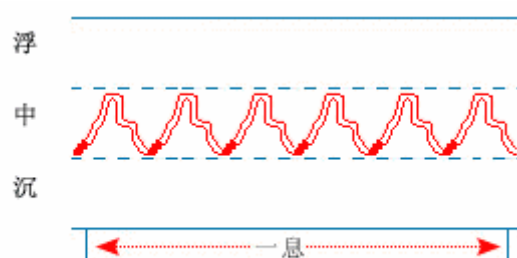


图 6-13 (1) 数脉示意图

【体象歌】数脉属阳，象为太过；一息六至，往来越度。

【主病歌】数脉主腑，其病为热。寸数喘咳，口疮肺⁵¹；关数胃热，邪火上攻；尺数相火，遗浊淋瘕。

【兼脉歌】有力实火，无力虚火。浮数表热，沉数里热。阳数君火，阴数相火。右数火亢，左数阴戕。

滑脉

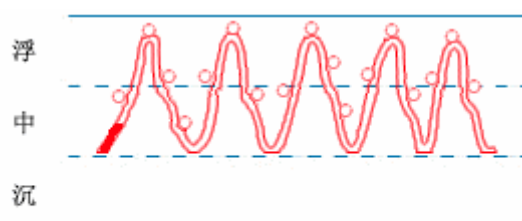


图 6-25 (1) 滑脉示意图

【体象歌】滑脉替替，往来流利；盘珠之形，荷露之义。

【主病歌】滑脉为阳，多主痰涎。寸滑咳嗽。胸满吐逆；关滑胃热，壅气伤食；尺滑病淋，或为痢积，男子溺血，妇人经郁。

【兼脉歌】浮滑风痰，沉滑痰食。滑数痰火，滑短气塞。滑而浮大，尿则阴痛。滑而浮散，中风瘫痪。滑而冲和，妊娠可决。

涩脉

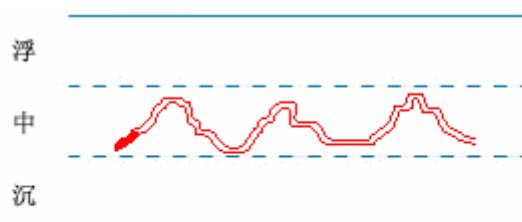


图 6-27 (1) 涩脉示意图

【体象歌】涩脉蹇滞，如刀刮竹；迟细而短，三象俱足。

【主病歌】涩为血少，亦主精伤。寸涩心痛，或为怔忡。关涩阴虚，因而中热；右关土虚，左关胁胀。尺涩遗淋，血利可决；孕为胎病，无孕血竭。

【兼脉歌】涩而坚大，为有实热；涩而虚软，虚火炎灼。

虚脉

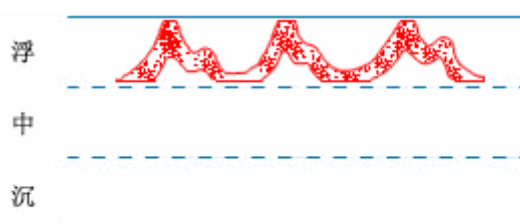


图 6-14 (1) 虚脉示意图

【体象歌】虚合四形，浮大迟软；及乎寻按，几不可见。

【主病歌】虚主血虚。又主伤暑。左寸心亏，惊悸怔忡；右寸肺亏，自汗气怯。左关肝伤，血不营筋；右关脾寒，食不消化。左尺水衰，腰膝痠痹；右尺火衰，寒证蜂起。

实脉

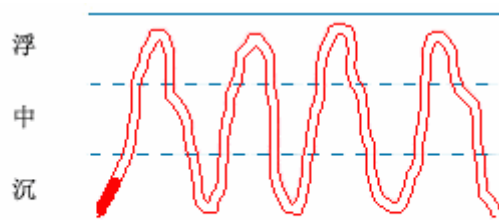


图 6-15 (1) 实脉示意图

【体象歌】实脉有力，长大而坚；应指幅幅，三候皆然。

【主病歌】血实脉实，火热壅结。左寸心劳，舌强气涌；右寸肺病，呕逆咽疼。左关见实，肝火胁痛；右关见实，中满气疼。左尺见之，便闭腹疼；右尺见之，相火亢逆。

【兼脉歌】实而且紧，寒积稽留。实而且滑，痰凝为祟。

长脉

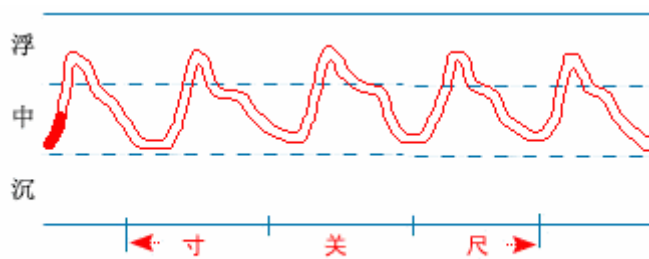


图 6-23 (1) 长脉示意图

【体象歌】长脉迢迢，首尾俱端；直上直下，如循长竿。

【主病歌】长主有余，气逆火盛。左寸见长，君火为病；右寸见长，满逆为定。左关见长，木实之殃；右关见长，土郁胀闷。左尺见之，奔豚冲兢；右尺见长，相火专令。

短脉

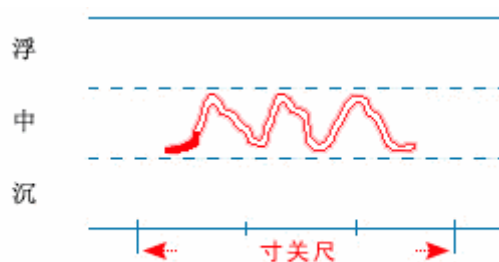


图 6-24 (1) 短脉示意图

【体象歌】短脉涩小，首尾俱俯；中间突起，不能满部。

【主病歌】短主不及，为气虚证。短居主寸，心神不定；短见右寸，肺虚头痛。短在左关，肝气有伤；短在右关，膈间为殃。左尺短时，少腹必疼；右尺短时，真火不隆。

洪脉



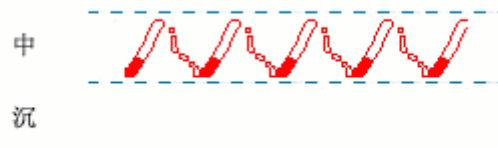


图 6-16 (1) 洪脉示意图

【体象歌】洪脉极大，状如洪水；来盛去表，滔滔满指。

【主病歌】洪为盛满，气壅火亢。左寸洪大，心烦舌破；右寸洪大，胸满气逆。左关见洪，肝木太过；右关见洪，脾土胀热。左尺洪兮，水枯便难；右尺洪兮，龙火燔灼。

微脉

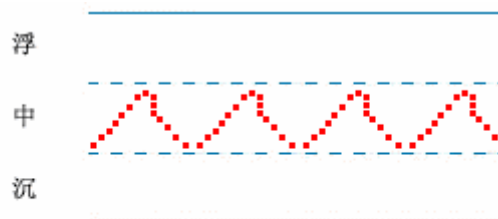


图 6-17 (1) 微脉示意图

【体象歌】微脉极细，而又极软；似有若无，欲绝非绝。

【主病歌】微脉模糊，气血大衰。左寸惊怯，右寸气促。左关寒挛。右关胃冷。左尺得微，髓竭精枯；右尺得微，阳衰命绝。

细脉

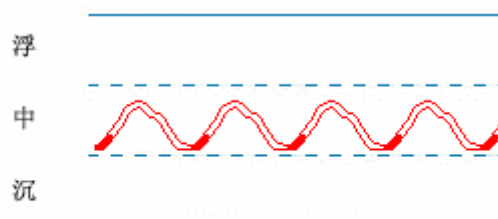


图 6-18 (1) 细脉示意图

【体象歌】细直而软，累累萦萦；状如丝线，较显于微。

【主病歌】细主气衰，诸虚劳损。细居左寸，怔忡不寐；细在右寸，呕吐气怯。细入左关，肝阴枯竭；细入右关，胃虚胀满。左尺若细，泄痢遗精；右尺若细，下元冷惫。

濡脉

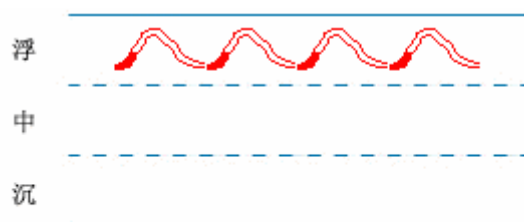


图 6-29 (1) 濡脉示意图

【体象歌】濡脉细软，见于浮分；举之乃见，按之即空。

【主病歌】濡主阴虚，髓绝精伤。左寸见濡，健忘惊悸；右寸见濡，腠虚自汗。左关逢之，血不营筋；右关逢之，脾虚湿浸。左尺得濡，精血枯损；右尺得之，火败命乖。

弱脉

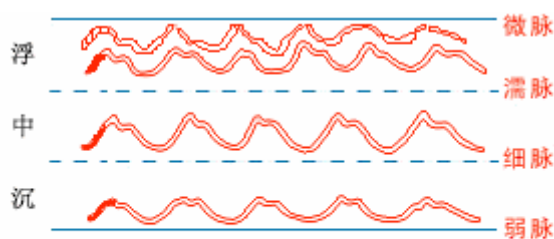


图 6-19 (1) 弱脉示意图

【体象歌】弱脉细小，见于沉分；举之则无，按之乃得。

【主病歌】弱为阳陷，真气衰弱。左寸心虚，惊悸健忘；右寸肺虚，自汗短气。左关木枯，必苦挛急；右关土寒，水谷之疴。左尺弱形，涸流可征；右尺弱见，阳陷可验。

紧脉

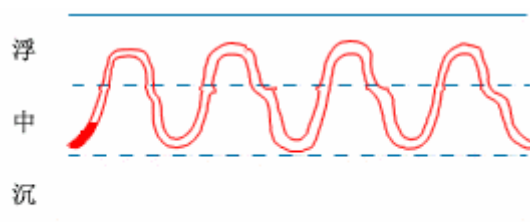


图 6-30 (1) 紧脉示意图

【体象歌】紧脉有力，左右弹指；如绞转索，如切紧绳。

【主病歌】紧主寒邪，又主诸痛。左寸逢紧，心满急痛；右寸逢紧，伤寒喘嗽。左关人迎，浮紧伤寒；右关气口，沉紧伤食。左尺见之，脐下痛极；右尺见之，奔豚疝疾。

缓脉

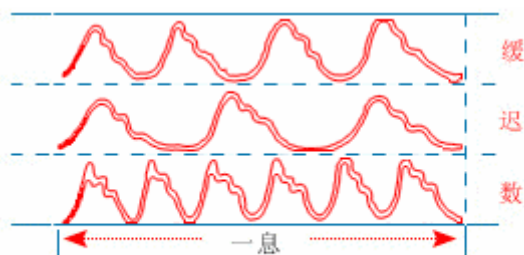


图 6-31 (1) 缓、迟、数脉示意图

【体象歌】缓脉四至，来往和匀；微风轻飏，初春杨柳。

【主病兼脉歌】缓为胃气，不主于病；取其兼见，方可断证。浮缓风伤，沉缓寒湿。缓大风虚，缓细湿痹。缓涩脾薄，缓弱气虚。右寸浮缓，风邪所居；左寸涩缓，少阴血虚。左关浮缓，肝风内鼓；右关沉缓。士弱湿侵。左尺缓涩，精宫不及；右尺缓细，真阳衰极。

弦脉

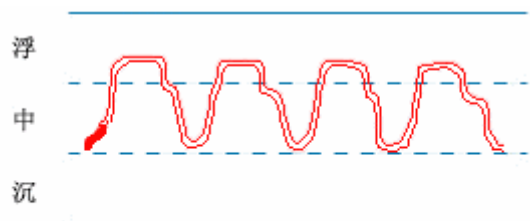


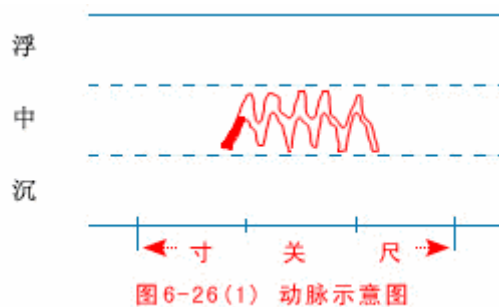
图 6-28 (1) 弦脉示意图

【体象歌】弦如琴弦，轻虚而滑；端直以长，指下挺然。

【主病歌】弦为肝风，主痛主疟，主痰主饮。弦在左寸，心中必痛；弦在右寸，胸及头疼。左关弦兮，痰疟癥瘕；右关弦兮，胃寒膈痛。左尺逢弦，饮在下焦；右尺逢弦，足挛疝痛。

【兼脉歌】浮弦支饮，沉弦悬饮。弦数多热，弦迟多寒。弦大主虚，弦细拘急。阳弦头痛，阴弦腹痛。单弦饮癖，双弦寒疝。

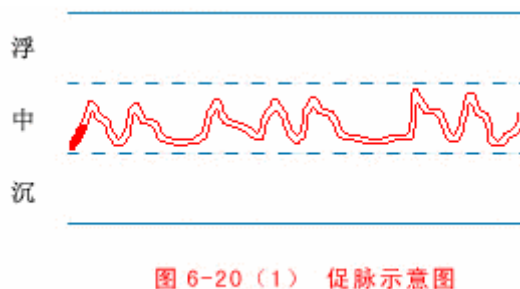
动脉



【体象歌】动无头尾，其动如豆；厥厥动摇，必兼滑数。

【主病歌】动脉主痛，亦主于惊。左寸得动，惊悸可断；右寸得动，自汗无疑。左关若动，惊及拘挛；右关若动，心脾疼痛。左尺见之，亡精为病；右尺见之，龙火奋迅。

促脉



【体象歌】促为急促，数时一止；如趋而蹶，进则必死。

【主病歌】促因火亢，亦由物停。左寸见促，心火炎炎；右寸见促，肺鸣咯咯。促见左关，血滞为殃；促居右关，脾宫食滞。左尺逢之，遗滑堪忧；右尺逢之，灼热为灾。

结脉

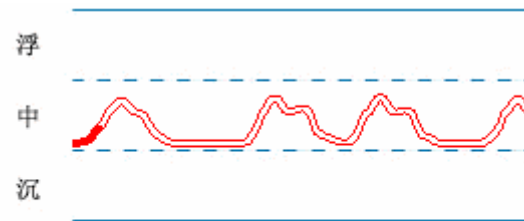


图 6-21 (1) 结脉示意图

【体象歌】结为凝结，缓时一止；徐行而怠，颇得其旨。

【主病歌】结属阴寒，亦由凝积。左寸心寒，疼痛可决；右寸肺虚，气寒凝结；左关结见，疝瘕必现；右关结形，痰滞食停。左尺结兮，痿痹之疴；右尺结兮，阴寒为楚。

代脉

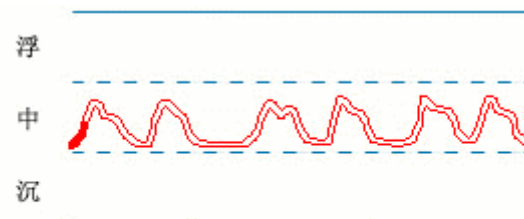


图 6-22 (1) 代脉示意图

【体象歌】代为禅代，止有常数；不能自还，良久复动。

【主病歌】代主脏衰，危恶之候。脾土败坏，吐利为咎；中寒不食，腹疼难救。两动一止，三四日死；四动一止，六七日死。次第推求，不失信旨。

革脉

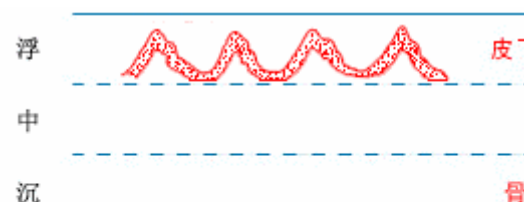


图 6-33 (1) 革脉示意图

【体象歌】革大弦急，浮取即得；按之乃空，浑如鼓革。

【主病歌】革主表寒，亦属中虚。左寸之革，心血虚痛；右寸之革，金衰气壅。左关遇之，疝瘕为祟；右关遇之，土虚为疼。左尺诊革，精空可必；右尺诊革，殒命为忧。女人得之，半产漏下。

牢脉

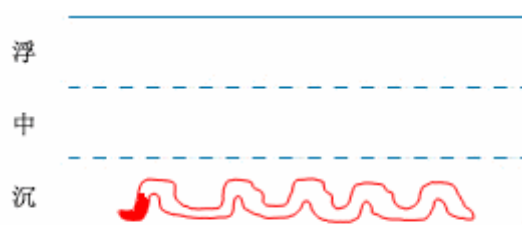


图 6-34 (1) 牢脉示意图

【体象歌】牢在沉分，大而弦实；浮中二候，了不可得。

【主病歌】牢主坚积。病在于内。左寸之牢，伏梁为病；右寸之牢，息贲可定。左关见牢，肝家血积；右关见牢，阴寒痞癖。左尺牢形，奔豚为患；右尺牢形，疝瘕痛甚。

散脉

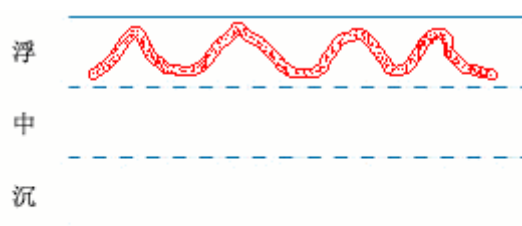


图 6-9 (1) 散脉示意图

【体象歌】散脉浮乱，有表无里；中候渐空，按则绝矣。

【主病歌】散为本伤，见则危殆。左寸之散，怔忡不寐；右寸之散，自汗淋漓。左关之散，当有溢饮；右关之散，胀满蛊疾。居于左尺，北方水竭；右尺得之，阳消命绝。

芤脉

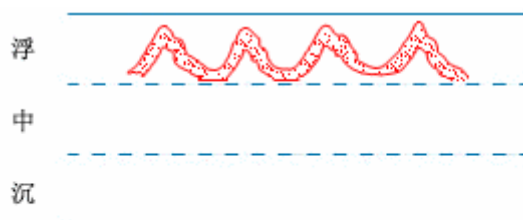


图 6-32 (1) 芤脉示意图

【体象歌】芤乃草名，绝类葱葱；浮沉俱有，中候独空。

【主病歌】芤脉中空，故主失血。左寸呈芤，心主丧血；右寸呈芤。相搏阴伤。芤入左关，肝血不藏；芤现右关，脾血不摄。左尺如芤，便红为咎；右尺如芤，火炎精漏。

伏脉

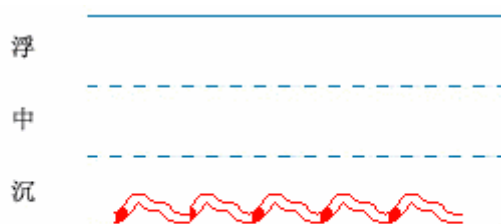
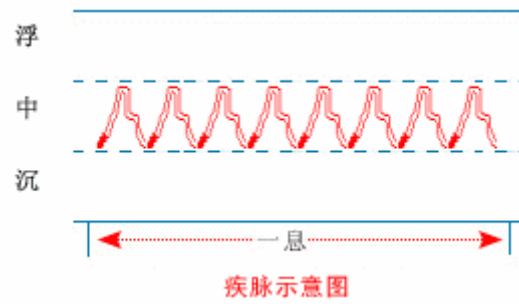


图 6-11 (1) 伏脉示意图

【体象歌】伏为隐伏，更下于沉；推筋著骨，始得其形。

【主病歌】伏脉为阴，受病入深。伏犯左寸，血郁之证；伏居右寸，气郁之疴。左关值伏，肝血在腹；右关值伏，寒凝水谷。左尺伏见，疝瘕可验；右尺伏藏，少火消亡。

疾脉

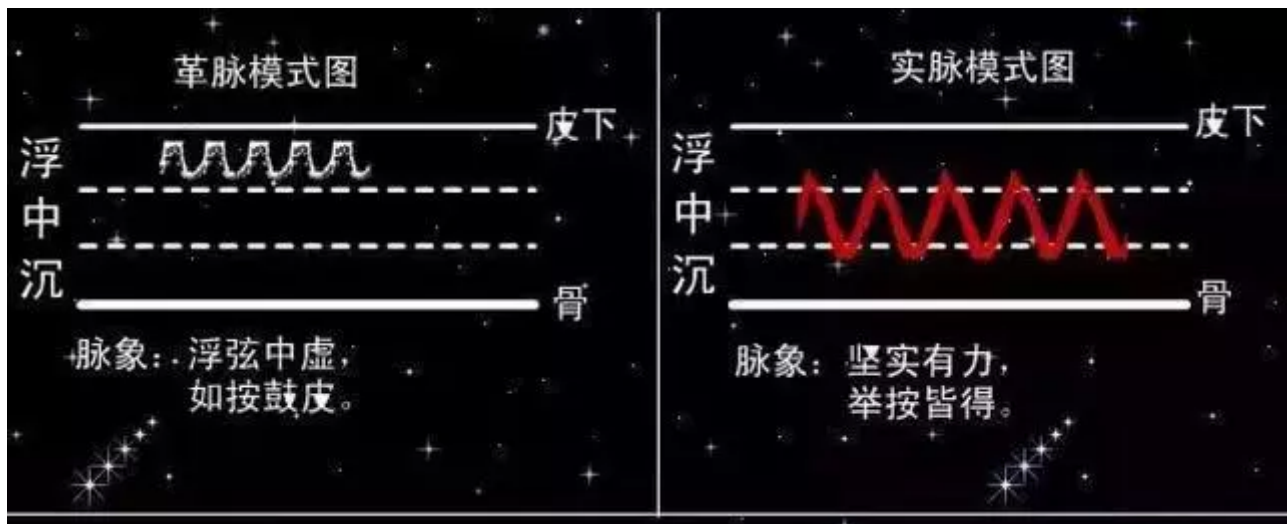


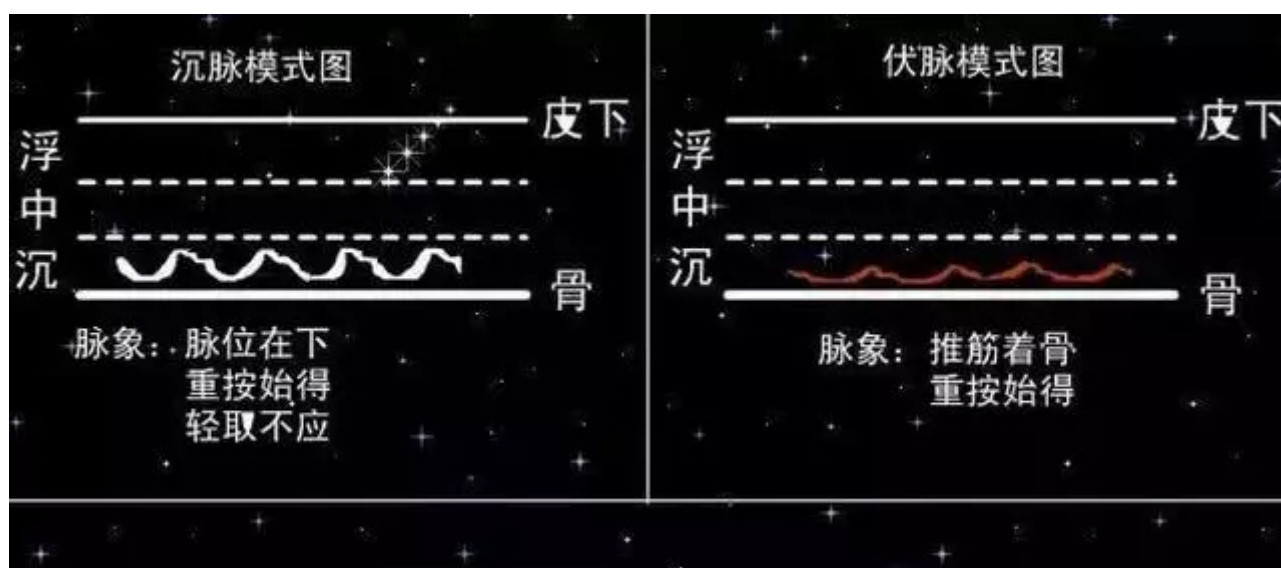
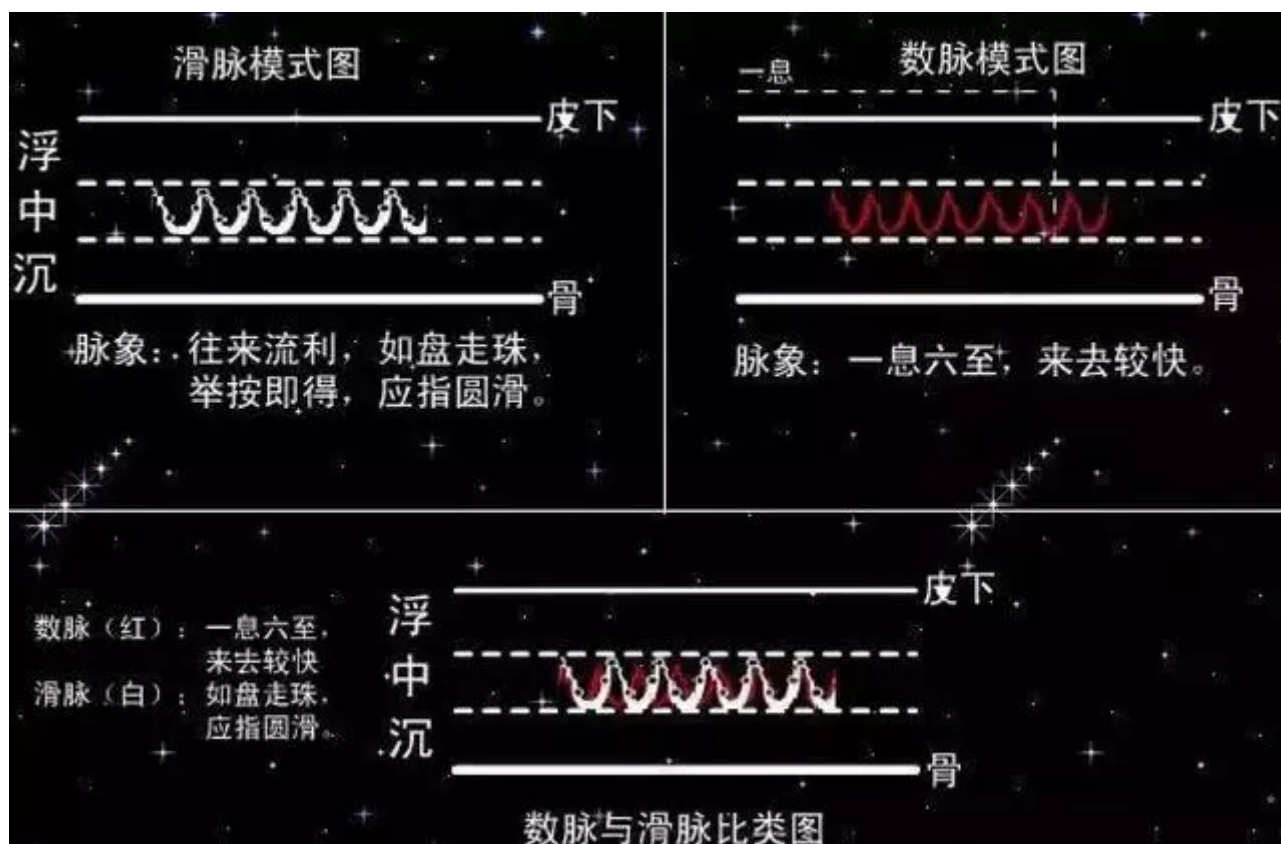
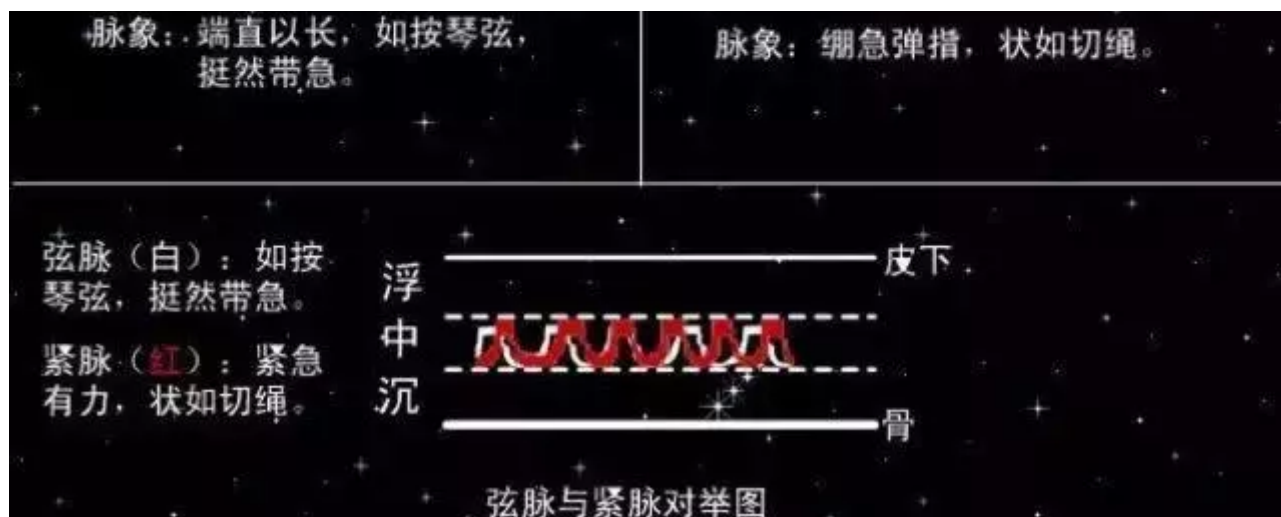
【体象歌】疾为急疾，数之至极；七至八至，脉流薄疾。

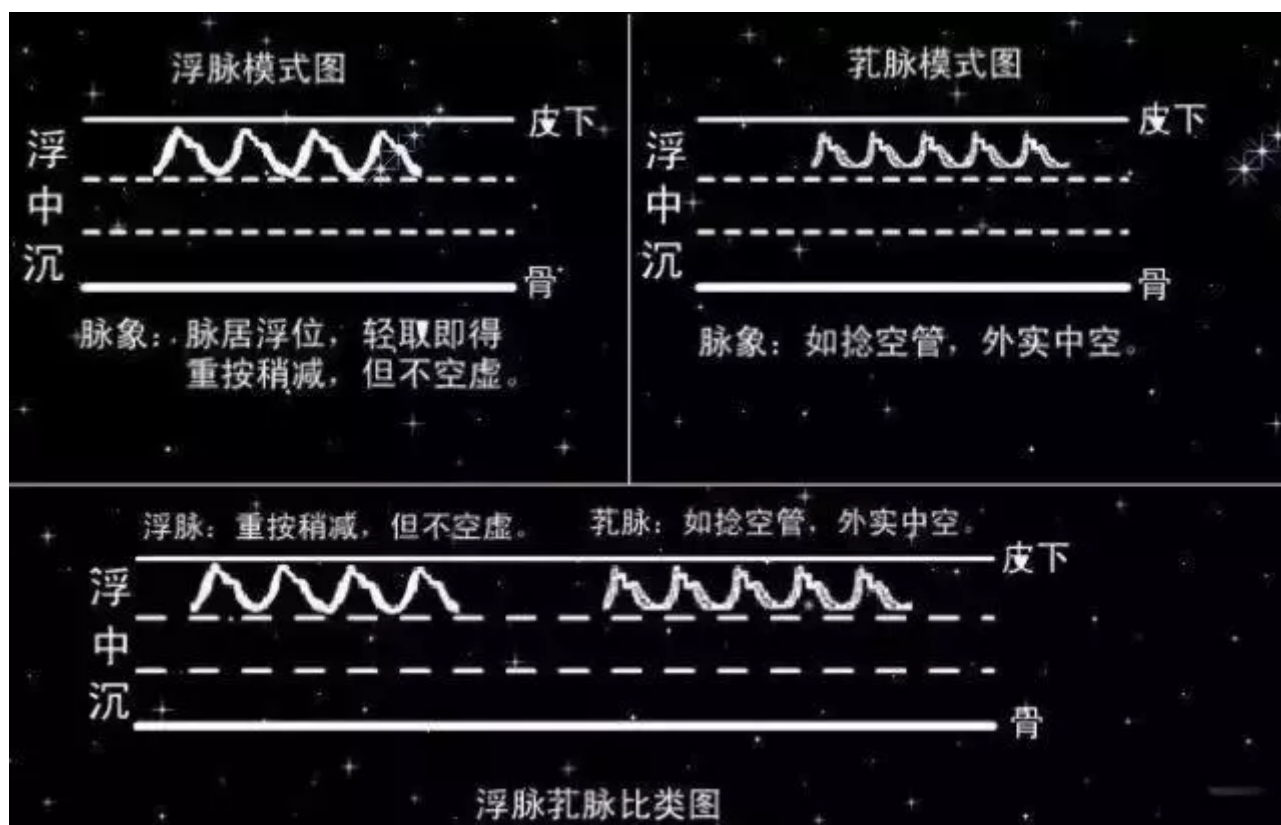
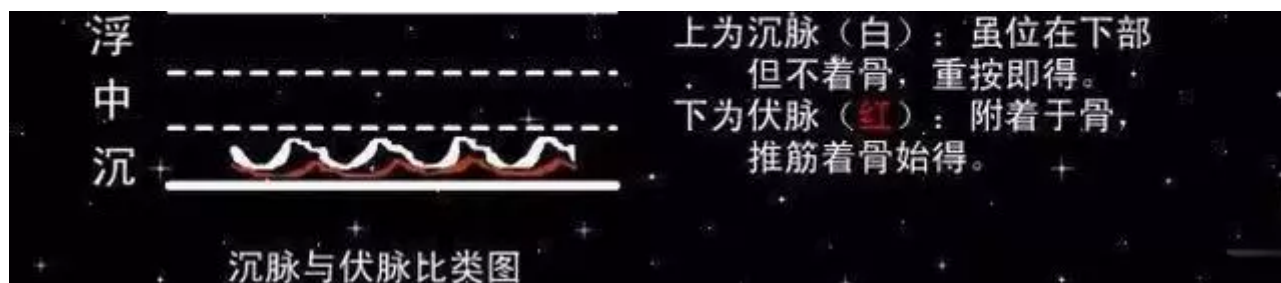
【主病歌】疾为阳极，阴气欲竭；脉号离经，虚魂将绝；渐进渐疾，且多殒灭。左寸居疾，勿戢自焚；右寸居疾，金被火乘。左关疾也，肝阴已绝；右关疾也，脾阴消竭。左尺疾兮，涸辙难濡；右尺疾兮。赫曦过极。

鉴别和对比

为了方便鉴别和对比，了解各种相似脉象的区别，二羊特意整理出对比图片，方便大家学习







以上图片内容来源互联网，中医二羊整理收藏。

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

iPhone 用户赞赏专用



中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色栀子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

长按指纹
一键关注



微信号: 济阳医斋



微信ID: yytcm100